

Crupe (laringotraqueíte) - estridor

Crupe viral: tosse metálica, rouquidão e estridor inspiratório. Corticoide é a base; adrenalina nebulizada na obstrução moderada-grave.

Droga-chave

Dica - Droga-chave

Dexametasona 0,15–0,6 mg/kg (dose única; tetos conforme protocolo) reduz sintomas e retorno. Budesonida neb é alternativa se VO inviável.

Escore de Westley (conceito): estridor em repouso e retrações definem intensificação.



Diferenciais

- Epigloteite: toxemia, babão, posição em tripé — não examine a garganta à força
- Corpo estranho: início súbito sem pródrômo viral
- Abscesso retrofaríngeo: febre, cervicalgia, limitação
- Traqueíte bacteriana: piora tóxica após crupe

Conduta por gravidade

Nível | Conduta

Leve | Dexametasona; alta

Moderado | Dexametasona + adrenalina; observar 2–3 h

Grave | Adrenalina seriada + via aérea pronta

Rx (se feito) | Sinal do campanário — não obrigatório

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Após adrenalina, observe — efeito pode rebote. Não agite criança com estridor grave; O , suplementar e minimal handling.